মানসম্পন্ন সেবাদানের কর্ম পরিকল্পনা

১. উদ্দেশ্যসমূহ (Objectives)

- চৌগাছা-ঝিনাইদহ আদর্শের মাপকাঠিতে SSK ভুক্ত সকল জেলা-উপজেলা হাসপাতালকে স্তরায়ন করা
- সকল জেলা-উপজেলা SSK উপজেলা কমিটি কমিউনিটি সহায়তা গ্রুপ হিসেবে কাজ করবে

২. লক্ষ্যমাত্রা (Target)

- ২০২৩ সালের ৩০শে জুনের মধ্যে টাঙ্গাইল জেলার সকল উপজেলা এবং বরগুনায়, লক্ষ্মীপুর, বরিশাল, মানিকগঞ্জ, লালমনিরহাট ও কুড়িগ্রাম জেলার কমপক্ষে একটি উপজেলায় চৌগাছা-ঝিনাইদহ (সি-জে) মডেলের আলোকে কার্যক্রম সম্প্রসারণের ব্যবস্থা করা।
- SSK ভুক্ত প্রতিটি জেলা ও উপজেলা হাসপাতাল্ের মানোন্নয়নে প্রাথমিক জরীপ সম্পন্ন করা
- 5S-KAIZEN-TQM এর প্রশিক্ষণ
- 5S-KAIZEN এর আলোকে স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সগুলোতে Quality Improvement Committee (QIC) এবং Work Improvement Team (WIT) কমিটি গঠন ও প্রাথমিক কার্যক্রম শুরু করা
- প্রতিটি জেলা ও উপজেলা হাসপাতালে স্থানীয়ভাবে মডেলের কিছু কিছু বৈশিষ্টের বাস্তবায়ন করা

৩. এ যাবত নেয়া কার্যক্রম (১লা এপ্রিল থেকে)

- প্রথম পর্যায়ের টাঙ্গাইল জেলার জেলা হাসপাতালসহ সকল উপজেলা হাসপাতাল পরিদর্শন সম্পন্ন।
- সাতটি জেলার মধ্যে দুইটি জেলায় SSK কার্যক্রম বাস্তবায়নে প্রাথমিক পর্যায়ে জেলা-উপজেলা পর্যায়ে কর্মকর্তা এবং জনপ্রতিনিধিদের সাথে SSK কার্যক্রম বাস্তবায়ন সংক্রান্ত আলোচনা সম্পন্ন।
- কর্মকৌশলের বাস্তবায়ন সংক্রান্ত আলোচনা সম্পন্ন।
- চৌগাছা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স পরিদর্শন সম্পন্ন। লক্ষ্মীপুর জেলার রামগতি এবং কমলনগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স পরিদর্শন এবং মূল্যায়ন কার্য সম্পন্ন।
- জরীপের জন্য প্রশ্নমালা প্রস্তুতকরন- আংশিক সম্পন্ন হয়েছে।
- চৌগাছা-ঝিনাইদহ মডেলের আলোকে SSK কার্যক্রমে যে সব জেলা-উপজেলায় স্বাস্থ্যসেবার উন্নয়ন করা হবে, সেখানে স্বল্প ও মধ্য মেয়াদে জেলা ও উপজেলা চিহ্নিত করা।

- ✓ যারা এই কাজ করবে তাদের নিয়ে স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইউনিটের পরিচালক (গবেষনা) এর সাথে বৈঠক এবং নিয়মিত পর্যালোচনা করা
- ✓ অবস্থিত ব্যবস্থার সাথে কোন কোন উপাদান যোগ করা হবে তা নির্ধারণ করা।
- ✓ খরচের হিসাব প্রস্তুত করা
- ✓ প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল প্রস্তুত করা এবং তা পরীক্ষা করা
- ✓ ক্লাস রুম প্রশিক্ষণের সাথে মেন্টরিং পদ্ধতির মিশ্রণ ঘটানো
- ✓ সকল পক্ষের অংশগ্রহণে মাঠ পর্যায়ে উদ্বুদ্ধকরণ সভা আয়োজন
- ✓ নিয়মিত তথ্য সংগ্রহ, পর্যবেক্ষণ, পরিবীক্ষণ করে উন্নতি পর্যালোচনা করা

৪. চৌগাছা-ঝিনাইদহ মডেল বাস্তবায়নের ধাপসমূহ:

১. জরিপ সম্পাদনের মাদ্যমে একটি প্রাথমিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন তৈরী করা
২. চৌগাছা-ঝিনাইদহ মডেলের বল্ডিং ব্লকের আলোকে প্রতিষ্ঠানের সমস্যাসমূহ চিহ্নিতকরণ
৩. প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের জন্য নির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা (Target) নির্ধারণ করা
৪. লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নে সেবাদানকারীদের অঙ্গীকার অর্জন করা
৫. মূল্যবোধ ভিত্তিক কর্মপরিবেশ ও প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কৃতি গড়ে তোলা
৬. মানসম্পন্ন সেবাদান বাস্তবায়নে 5S-KAIZEN পদ্ধতি বাস্তবায়ন করা। এই সংক্রান্ত একটি কর্মশালার ব্যবস্থা করা
৭. প্রতিষ্ঠানে QIC এবং WIT টিমসমূহ গঠন করা
৮. চৌগাছা-ঝিনাইদহ মডেলের বিল্ডিং ব্লক্সমূহ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে SOP প্রস্তুতকরণ
৯. চৌগাছা-ঝিনাইদহ স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনের মাধ্যমে বাস্তব জ্ঞান অর্জন করা
১০. মডেল সম্পর্কে অভিজ্ঞ টেকনিকাল টিম গঠনের মাধ্যমে স্থানীয় স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানে মডেল হাতে কলমে বাস্তবায়ন করা
১১. উপজেলা SSK কমিটিকে সক্রিয় করা
১২. কার্যক্রমের অগ্রগতি মূল্যায়ন করা

৫. সি-জে মডেল বাস্তবায়ন উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স (QIC)কমিটি

ক্রমিক	কর্মকর্তা/ জনপ্রতিনিধির পদবী	কমিটিতে পদ
১.	উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা	চেয়ারপারসন
২.	আবাসিক মেডিক্যাল অফিসার	সদস্য সচিব ও ফোকাল পারসন
৩.	ডাব্লুআইটি কমিটিসমূহের টিম লিডার ও ফ্যাসিলিটেটরগণ	সদস্য

কর্মপরিধি

১. প্রতি মাসে একবার সভা অনুষ্ঠান করবে
২. কমিউনিটি হতে কোন্ ধরণের সহযোগিতা নেবে তার সুপারিশ তৈরী করবে
৩. প্রতিটি ডাব্লুআইটি কার্যক্রমের বাস্তবায়নের অগ্রগতি মূল্যায়ন করবে
৪. ঊর্ধতন কর্তৃপক্ষকে মাসের প্রথম সপ্তাহে নির্ধারিত ছকে প্রতিবেদন প্রেরণ করবেন

৬. সি-জে মডেল বাস্তবায়ন উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স এর প্রতিটি ওয়ার্ডে (WIT)কমিটি

ক্রমিক	কর্মকর্তা/ জনপ্রতিনিধির পদবী	কমিটিতে পদ
১.	আবাসিক মেডিক্যাল অফিসার/কনসালটেন্ট	টিম লিডার
২.	ওয়ার্ড ইনচার্জ নার্স/মেডিকেল এসিস্টেন্ট, অফিস সহকারি	সদস্য সচিব
৩.	ওয়ার্ডের সকল নার্স, আয়া, ওয়ার্ডবয়, ক্লিনার	সদস্য

কর্মপরিধি

১. প্রতি সপ্তাহে অফিস শুরুর ১৫ মিনিট স্থায়ী একবার সভা অনুষ্ঠান করবে
২. কমিউনিটি হতে কোন্ ধরণের সহযোগিতা নেবে তার সুপারিশ তৈরী করবে
৩. ওয়ার্ডের সমস্যা চিহ্নিত করা ও বাস্তবায়নের অগ্রগতি মূল্যায়ন করবে
৪. ঊর্ধতন কর্তৃপক্ষকে প্রতি সপ্তাহে QIC কে নির্ধারিত ছকে প্রতিবেদন প্রেরণ করবেন

৭. প্রাতিষ্ঠানিক বাস্তবায়নসূচী:

নং	কর্মসূচি	বাস্তবায়নকারী	সময়সীমা
১.	QIC এবং WIT কমিটি গঠন	স্থানীয় হাসপাতাল/উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স কর্তৃপক্ষ	৭ দিন
২.	প্রাথমিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রস্তুতকরণ	কিউআইসি ও ডাব্লুআইটি দল	১০ দিন
৩.	সমস্যাসমূহ চিহ্নিতকরণ	কিউআইসি ও ডাব্লুআইটি দল	১৫ দিন
৪.	লক্ষ্য এবং লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ	কিউআইসি দল	৫ দিন
৫.	লক্ষ্যসমূহ বাস্তবায়নে জনগোষ্ঠী ও সেবাদানকারীদের অঙ্গিকার অর্জনে কর্মশালার মাধ্যমে উদ্বুদ্ধকরণ	স্থানীয় হাসপাতাল/উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স কর্তৃপক্ষ	৩০ দিন
৬.	প্রয়োজনীয় সামগ্রীর তালিকা প্রস্তুত ও সংগ্রহ	স্থানীয় হাসপাতাল/উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স কর্তৃপক্ষ	২০ দিন
৭.	মূল্যবোধভিত্তিক কর্মপরিবেশ ও প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কৃতি গড়ে তোলার নীতিমালা প্রস্তুত করা	কিউআইসি দল	৩০ দিন

৮.	লক্ষ্য বাস্তবায়নে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য সকল অংশীজনের সাথে মতবিনিময়	কমিউনিটি সহায়তা গ্রুপ ও স্থানীয় স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষ	৩০ দিন
৯.	মানসম্পন্ন সেবাদানে ৫এস কাইজেন পদ্ধতি বিষয়ে প্রশিক্ষণ	স্থানীয় স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষ	৭ দিন
১০.	প্রতিটি প্রশিক্ষণার্থী দল কর্তৃক চৌগাছা ও ঝিনাইদহ স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনের মাধ্যমে বাস্তব জ্ঞান অর্জন	জাতীয় টেকনিক্যাল কমিটি	---------
১১.	মডেল সম্পর্কে অভিজ্ঞ বিশেষজ্ঞ দল কর্তৃক স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানে মডেল হাতে কলমে বাস্তবায়নের জন্য সফর	জাতীয় টেকনিক্যাল কমিটি	৭ দিন
১২.	কার্যক্রমের অগ্রগতি মূল্যায়ন	স্থানীয় স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষ	প্রতি ৪৫ দিন অন্তর

৮. Status of Building Blocks of C-J Model in the UHC:

Sl	Criteria of C-J Model	Satisfactory	Average	Unsatisfactory
1.	Cycle stand close to the main gate			
2.	Health Education			
3.	Cleanliness & beautification			
4.	Separation of patients in out door & indoor			
5.	Blood doner list with 24/7 B.T facility			
6.	Birth- death recording			
7.	Reception Desk			
8.	Developed Emergency Dept.			
9.	5S –KAIZEN implementation.			
10.	Community Participation.			
11.	Hospital activities Display			
12.	Corner based service.			
13.	Cash counter for receiving Govt money.			
14.	Devolped maternal health/labour word.			
15.	Devolped paediatric health			
16.	Position in HSS score (Best= <100; Good= 101-200; Weak= >200)			
17.	Power point Presentation &Video on UHC			
18.	Knowledge about 8th Five Year plan & SDG.			
19.	Zero-Tollarance on corruption			

৯. মূল্যায়নের জন্য প্রশ্নমালা:

ক) উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের ক্ষেত্রে:

১)	উপজেলার নাম:		
২)	ক. ইউএইচএফপিও'র নাম:		
	খ. মোবাইল নং:		
	গ. ই-মেইল:		
৩)	হাসপাতালের শয্যা সংখ্যা		
৪)	উপজেলার তথ্য		
	ক. উপজেলার মোট জনসংখ্যা		
	খ. মোট গর্ভবতী মায়ের সংখ্যা		
	গ. মোট ০-১ বছরের শিশু সংখ্যা		
	ঘ. মোট ০-৫ বছরের শিশু সংখ্যা		
৫)	মাসিক এইচএসএস নম্বরে সর্বশেষ অবস্থান		
	ক. সর্বনিম্ন: (বর্তমান বছরে)		
	খ. সর্বোচ্চ: (বর্তমান বছরে)		
৬)	বায়োমেট্রিক হাজিরাঃ আগের মাসের (%)		
	ক. সর্বোচ্চ (বর্তমান বছরে)		
	খ. সর্বনিম্ন (বর্তমান বছরে)		
৭)	মানবসম্পদ	পদ সংখ্যা	শুন্যপদ
	১.ক. চিকিৎসক		
	১.খ. মেডিকেল অফিসার		
	১.গ. মেডিকেল অফিসার (ওএসডি)		
	১.ঘ. কনসালটেন্ট		
	২. ক. নার্স		
	২. খ. মিড-ওয়াইফ		
	৩. পরিচ্ছন্ন কর্মী		
	৪. ওয়ার্ড বয়/আয়া		
৮)	মোট রোগীর সংখ্যা (আগের মাসের)		
	ক. অন্তঃবিভাগ		
	খ. জরুরী বিভাগ		
	গ. বহিঃবিভাগ		
৯)	শয্যা ব্যবহারের হার (%) (আগের মাসের)		
১০)	মোট গর্ভবতী পরিচর্যা (আগের মাসের)		
	ক. ১ম ভিজিট (সংখ্যা)		
	খ. চতুর্থ ভিজিট (সংখ্যা)		
	গ. মোট (সংখ্যা)		
১১)	মোট প্রসব সংখ্যা (আগের মাসের)		

	ক. মোট স্বাভাবিক প্রসব		
	খ. মোট সিজারিয়ান প্রসব		
	গ. রাতে সিজারিয়ান প্রসব		
১২)	মৃত জন্ম শিশুর সংখ্যা (আগের মাসের)		
১৩)	নবজাতক শিশু মৃত্যুর সংখ্যা (আগের মাসের)		
১৪)	হাসপাতালে মাতৃমৃত্যুর সংখ্যা (আগের মাসের)		
১৫)	মোট প্রসবোত্তর পরিচর্যা (আগের মাসের)		
১৬)	মেজর (বড়) অপারেশন (আগের মাসের)		
	ক. জেনারেল সার্জারি (সংখ্যা)		
	খ. গাইনি/অবস (সংখ্যা)		
	গ. ডেন্টাল অপারেশন (সংখ্যা)		
	ঘ. মোট মেজর অপারেশন (সংখ্যা)		
১৭)	ভায়া পরীক্ষার সংখ্যা (সর্বমোট) (আগের মাসের)		
	ক. পজিটিভ (সংখ্যা)		
	খ. নেগেটিভ (সংখ্যা)		
১৮)	সর্বক্ষণিক রক্ত পরিসঞ্চালন কার্যক্রম	হ্যাঁ	না
১৯)	রোগ নির্ণয় ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা (চালু কি না)		
	১.ক. আল্ট্রাসনোগ্রাফি	হ্যাঁ	না
	১.খ. এক্স-রে	হ্যাঁ	না
	১.গ. ই.সি.জি	হ্যাঁ	না
	২. ক. সি.বি.সি	হ্যাঁ	না
	২.খ. বায়োকেমিস্ট্রি ও ইমিউনোলোজি	হ্যাঁ	না
	২.খ.১. লিপিড প্রোফাইল	হ্যাঁ	না
	২.খ.২. সেরাম ইলেক্ট্রোলাইট	হ্যাঁ	না
	২.খ.৩. সেরাম ক্রিয়েটিনিন	হ্যাঁ	না
	২.খ.৪. সেরাম ইউরিয়া	হ্যাঁ	না
	৩. ক. এইস.বি.এস. এ.জি	হ্যাঁ	না
	৩.খ. ব্লাড গ্লুকোজ	হ্যাঁ	না
	৩. গ. রক্তগ্রুপ ও স্ক্রিনিং	হ্যাঁ	না
২০)	চিকিৎসকদের আবাসিক (হাসপাতাল ক্যাম্পাসে) অবস্থান		
২১)	ক. ইউএইচএফপিও	হ্যাঁ	না
	খ. আবাসিক মেডিক্যাল অফিসার	হ্যাঁ	না
	গ. কনসালটেন্ট, মেডিসিন	হ্যাঁ	না
	ঘ. কনসালটেন্ট, সার্জারি	হ্যাঁ	না
	ঙ. কনসালটেন্ট, এনেসথেসিয়া	হ্যাঁ	না
	চ. কনসালটেন্ট, অবস গাইনি	হ্যাঁ	না

	ছ. কনসালটেন্ট, শিশু স্বাস্থ্য	হ্যাঁ	না
২২)	নার্স/অন্যান্যদের আবাসিক অবস্থান		
	ক. নার্সিং সুপারভাইজার	হ্যাঁ	না
	খ. ওটি সিস্টার	হ্যাঁ	না
	গ. ইওসি সিস্টার	হ্যাঁ	না
	ঘ. ইমার্জেন্সি ইন চার্জ	হ্যাঁ	না
	ঙ. স্টোর ইন চার্জ	হ্যাঁ	না
	চ. প্রধান অফিস সহকারি	হ্যাঁ	না
২৩)	কমিউনিটি সহায়তা গ্রুপ গঠন	হ্যাঁ	না
২৪)	কমিউনিটি হতে প্রাপ্ত সহযোগিতার পরিমাণ		
	ক. জনবল সহায়তা		
	খ. চিকিৎসা সামগ্রী সহায়তা		
	গ. আর্থিক সহায়তার পরিমাণ		
২৫)	মাসিক সভার সংখ্যা (আগের মাসের)		
	ক. স্বাস্থ্য সেবা উন্নয়ন কমিটি		
	খ. কমিউনিটি সহায়তা গ্রুপ		
	গ. সমন্বয় কমিটি		
	ঘ. কিউআইসি কমিটি		
	ঙ. ডাব্লুআইটি কমিটির সংখ্যা		
	চ. ডাব্লুআইটি কমিটির সভার সংখ্যা		
	ছ. ইওসি কমিটি		
২৬)	অভ্যর্থনা/তথ্য কেন্দ্র	হ্যাঁ	না
২৭)	হাসপাতালের প্রবেশ পথে সাইকেল স্ট্যান্ড	হ্যাঁ	না
২৮)	বহিঃবিভাগে রোগী পৃথকীকরণের ব্যবস্থা		
	ক. পুরুষ	হ্যাঁ	না
	খ. নারী	হ্যাঁ	না
	গ. শিশু	হ্যাঁ	না
	ঘ. প্রসূতি ও গাইনি	হ্যাঁ	না
২৯)	অন্তঃবিভাগে রোগী পৃথকীকরণের ব্যবস্থা		
	ক. পুরুষ	হ্যাঁ	না
	খ. নারী	হ্যাঁ	না
	গ. শিশু	হ্যাঁ	না
	ঘ. প্রসূতি ও গাইনি	হ্যাঁ	না
৩০)	বিষয়ভিত্তিক কর্নারের কার্যকারিতা		
	ক. এএনসি	হ্যাঁ	না
	খ. পিএনসি	হ্যাঁ	না
	গ. ভায়া	হ্যাঁ	না
	ঘ. ইপিআই	হ্যাঁ	না

	ঙ. এনসিডি	হ্যাঁ	না
	চ. ইপিআই/মাতৃদুগ্ধ পান	হ্যাঁ	না
	ছ. স্বাস্থ্য শিক্ষা	হ্যাঁ	না
৩১)	দর্শনার্থী নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম	হ্যাঁ	না
৩২)	রাত্রীকালীন ওয়ার্ড পরিদর্শন		
	ক. ইউএইচএফপিও	হ্যাঁ	না
	খ. আবাসিক মেডিকেল অফিসার	হ্যাঁ	না
	গ. নার্সিং সুপারভাইজার	হ্যাঁ	না
৩৩)	কনসালটেন্টদের রাত্রিকালীন ওয়ার্ড পরিদর্শন		
	ক. মেডিসিন	হ্যাঁ	না
	খ. সার্জারি	হ্যাঁ	না
	গ. গাইনি	হ্যাঁ	না
	ঘ. শিশু	হ্যাঁ	না
৩৪)	রাত্রীকালীন জরুরী অপারেশন সুবিধা		
	ক. সাধারণ সার্জারি	হ্যাঁ	না
	খ. ইওসি	হ্যাঁ	না
৩৫)	রোগীদের খাবার সরবরাহ তদারকি		
	ক. প্রতিদিন রোগীদের খাবার সামগ্রী কোনো কর্মকর্তা বুঝে নেন কি না?	হ্যাঁ	না
	খ. রান্না করা রোগীর খাদ্য কর্মকর্তা পরীক্ষা করেন কি না?	হ্যাঁ	না
৩৬)	এম্বুলেন্স সার্ভিস		
	ক. সচল কি না	হ্যাঁ	না
	খ. এম্বুলেন্স সার্ভিস থেকে আয় (আগের মাসের)		
	গ. এম্বুলেন্সের তেল বাবদ কত বাকি		
৩৭)	বাৎসরিক মোট মৃত্যুর সংখ্যা		
৩৮)	মাসিক মৃত্যু পর্যালোচনা	হ্যাঁ	না
৩৯)	পৌরসভায় বাৎসরিক কর প্রদানের পরিমাণ		
৪০)	বাৎসরিক মোট রাজস্ব আয়		

বছর	**ইমার্জেন্সি**	**আউটডোর**	**ইনডোর**	**ইওসি ভর্তি**	**শয্যা ব্যবহারের হার (%)**
২০১৮					
২০১৯					
২০২০					
২০২১					
২০২২					

নিরাপদ মাতৃত্বসেবা

বছর	গর্ভবতী সংক্রান্ত ১ম ভিজিট	গর্ভবতী সংক্রান্ত ৪র্থ ভিজিট	সর্বমোট ডেলিভারি	ডেলিভারি		পিএনসি	
				নরমাল	সিজার	পিএনসি ১ম	সর্বমোট ডেলিভারি
২০১৮							
২০১৯							
২০২০							
২০২১							
২০২২							

খ) জেলা হাসপাতালের ক্ষেত্রে:

১)	জেলার নাম:		
২)	ক. তত্ত্বাবধায়কের নাম:		
	খ. মোবাইল নং:		
	গ. ই-মেইল:		
৩)	জেলা হাসপাতালের শয্যা সংখ্যা		
৪)	জেলার তথ্য		
	ক. জেলার মোট জনসংখ্যা		
	খ. মোট গর্ভবতী মায়ের সংখ্যা		
	গ. মোট ০-১ বছরের শিশু সংখ্যা		
	ঘ. মোট ০-৫ বছরের শিশু সংখ্যা		
৫)	মাসিক এইচএসএস নম্বরে অবস্থান		
	ক. সর্বনিম্ন: (বর্তমান বছরে)		
	খ. সর্বোচ্চ: (বর্তমান বছরে)		
৬)	বায়োমেট্রিক হাজিরাঃ আগের মাসের (%)		
	ক.সর্বোচ্চ (বর্তমান বছরে)		
	খ.সর্বনিম্ন (বর্তমান বছরে)		
৭)	মানবসম্পদ	পদ সংখ্যা	শুন্যপদ
	১.ক. চিকিৎসকঃ		
	১.খ. মেডিকেল অফিসার		
	১.গ. মেডিকেল অফিসার (ওএসডি)		
	১.ঘ. কনসালটেন্ট		
	২. ক. নার্স		
	২. খ. মিড-ওয়াইফ		
	৩. পরিচ্ছন্ন কর্মী		
	৪. ওয়ার্ড বয়/আয়া		
৮)	মোট রোগীর সংখ্যা (আগের মাসের)		
	ক. অন্তঃবিভাগ		
	খ. জরুরী বিভাগ		
	গ. বহিঃবিভাগ		
৯)	শয্যা ব্যবহারের হার (%) (আগের মাসের)		
১০)	মোট গর্ভবতী পরিচর্যা (আগের মাসের)		
	ক. ১ম ভিজিট (সংখ্যা)		
	খ. চতুর্থ ভিজিট (সংখ্যা)		
	গ. মোট (সংখ্যা)		
১১)	মোট প্রসব সংখ্যা (আগের মাসের)		
	ক. মোট স্বাভাবিক প্রসব		

	খ. মোট সিজারিয়ান প্রসব		
	গ. রাতে সিজারিয়ান প্রসব		
১২)	মৃত জন্ম শিশুর সংখ্যা (আগের মাসের)		
১৩)	নবজাতক শিশু মৃত্যুর সংখ্যা (আগের মাসের)		
১৪)	হাসপাতালে মাতৃমৃত্যুর সংখ্যা (আগের মাসের)		
১৫)	মোট প্রসবোত্তর পরিচর্যা (আগের মাসের)		
১৬)	মেজর (বড়) অপারেশন (আগের মাসের)		
	ক. জেনারেল সার্জারি (সংখ্যা)		
	খ. গাইনি/অবস (সংখ্যা)		
	গ. অর্থোপেডিক (সংখ্যা)		
	ঘ. নাক-কান-গলা অপারেশন (সংখ্যা)		
	ঙ. চক্ষু অপারেশন (সংখ্যা)		
	চ. ডেন্টাল অপারেশন (সংখ্যা)		
	ছ. মোট মেজর অপারেশন (সংখ্যা)		
১৭)	সার্বক্ষণিক রক্ত পরিসঞ্চালন কার্যক্রম	হ্যাঁ	না
১৮)	রোগ নির্ণয় ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা (চালু কি না)		
	১.ক. আল্ট্রাসনোগ্রাফি	হ্যাঁ	না
	১.খ. এক্স-রে	হ্যাঁ	না
	১.গ. ই.সি.জি	হ্যাঁ	না
	২.ক. সি.বি.সি	হ্যাঁ	না
	২.খ. বায়োকেমিস্ট্রি ও ইমিউনোলোজি	হ্যাঁ	না
	২.খ.১. লিপিড প্রোফাইল	হ্যাঁ	না
	২.খ.২. সেরাম ইলেক্ট্রোলাইট	হ্যাঁ	না
	২.খ.৩. সেরাম ক্রিয়েটিনিন	হ্যাঁ	না
	২.খ.৪. সেরাম ইউরিয়া	হ্যাঁ	না
	৩.ক. এইস.বি.এস. এ.জি	হ্যাঁ	না
	৩.খ. ব্লাড গ্লুকোজ	হ্যাঁ	না
	৩. গ. রক্তগ্রুপ ও স্ক্রিনিং	হ্যাঁ	না
১৯)	চিকিৎসকদের আবাসিক (হাসপাতাল ক্যাম্পাসে) অবস্থান		
	ক. তত্ত্বাধায়ক	হ্যাঁ	না
	খ. আবাসিক মেডিক্যাল অফিসার	হ্যাঁ	না
	গ. কনসালটেন্ট, মেডিসিন	হ্যাঁ	না
	ঘ. কনসালটেন্ট, সার্জারি	হ্যাঁ	না
	ঙ. কনসালটেন্ট, এনেসথেসিয়া	হ্যাঁ	না
	চ. কনসালটেন্ট, অবস গাইনি	হ্যাঁ	না
	ছ. কনসালটেন্ট, অর্থোপেডিকস	হ্যাঁ	না
	জ. কনসালটেন্ট, কার্ডিওলজি	হ্যাঁ	না

	ঝ. কনসালটেন্ট, শিশু স্বাস্থ্য	হ্যাঁ	না
	ঞ. কনসালটেন্ট, নাক,কান, গলা	হ্যাঁ	না
	ট. কনসালটেন্ট চক্ষু	হ্যাঁ	না
২০)	নার্স/অন্যান্যদের আবাসিক অবস্থান		
	ক. নার্সিং সুপার	হ্যাঁ	না
	খ. ওটি সিস্টার	হ্যাঁ	না
	গ. ইওসি সিস্টার	হ্যাঁ	না
	ঘ. ইমার্জেন্সি ইন চার্জ	হ্যাঁ	না
	ঙ. স্টোর ইন চার্জ	হ্যাঁ	না
	চ. প্রধান অফিস সহকারি	হ্যাঁ	না
২১)	কমিউনিটি সহায়তা গ্রুপ গঠন	হ্যাঁ	না
২২)	কমিউনিটি হতে প্রাপ্ত সহযোগিতা		
	ক. জনবল সহায়তা		
	খ. চিকিৎসা সামগ্রী সহায়তা		
	গ. আর্থিক সহায়তার পরিমাণ		
২৩)	মাসিক সভার সংখ্যা (আগের মাসের)		
	ক. স্বাস্থ্য সেবা উন্নয়ন কমিটি		
	খ. কমিউনিটি সহায়তা কমিটি		
	গ. সমন্বয় কমিটি		
	ঘ. কিউআইসি কমিটি		
	ঙ. ডাব্লুআইটি কমিটি (প্রতি সপ্তাহে সভার সংখ্যা)		
২৪)	অভ্যর্থনা/তথ্য কেন্দ্র	হ্যাঁ	না
২৫)	হাসপাতালের প্রবেশ পথে সাইকেল স্ট্যান্ড	হ্যাঁ	না
২৬)	বিষয়ভিত্তিক কর্নারের কার্যকারিতা		
	ক. এএনসি	হ্যাঁ	না
	খ. পিএনসি	হ্যাঁ	না
	গ. ভায়া	হ্যাঁ	না
	ঘ. ইপিআই	হ্যাঁ	না
	ঙ. এনসিডি	হ্যাঁ	না
	চ. মাতৃদুগ্ধ পান	হ্যাঁ	না
	ছ. স্বাস্থ্য শিক্ষা	হ্যাঁ	না
২৭)	দর্শনার্থী নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম	হ্যাঁ	না
২৮)	রাত্রীকালীন ওয়ার্ড পরিদর্শনঃ		
	ক. তত্ত্বাবধায়ক নার্সিং	হ্যাঁ	না
	খ. আবাসিক মেডিকেল অফিসার	হ্যাঁ	না
	গ. নার্সিং সুপার	হ্যাঁ	না
২৯)	কনসালটেন্টদের রাত্রিকালীন ওয়ার্ড পরিদর্শন		

	ক. মেডিসিন	হ্যাঁ	না
	খ. সার্জারি	হ্যাঁ	না
	গ. গাইনি	হ্যাঁ	না
	ঘ. ইএনটি	হ্যাঁ	না
	ঙ. অর্থোপেডিকস	হ্যাঁ	না
	চ. চক্ষু	হ্যাঁ	না
	ছ. কার্ডিওলজি	হ্যাঁ	না
	জ. শিশু	হ্যাঁ	না
৩০)	রাত্রীকালীন জরুরী অপারেশন সুবিধা		
	ক. সাধারণ সার্জারি	হ্যাঁ	না
	খ. ইওসি	হ্যাঁ	না
	গ. অর্থোপেডিক	হ্যাঁ	না
	ঘ. চক্ষু	হ্যাঁ	না
	ঙ. নাক-কান-গলা	হ্যাঁ	না
৩১)	রোগীদের খাবার সরবরাহ তদারকি: ক) প্রতিদিন রোগীদের খাবার সামগ্রী কোনো কর্মকর্তা বুঝে নেন কিনা?	হ্যাঁ	না
	খ)রান্না করা রোগীর খাদ্য কর্মকর্তা পরীক্ষা করেন কিনা?	হ্যাঁ	না
৩২)	বাৎসরিক মোট রাজস্ব আয়		
৩৩)	বাৎসরিক মোট মৃত্যুর সংখ্যা		
৩৪)	মাসিক মৃত্যু পর্যালোচনা	হ্যাঁ	না
৩৫)	এম্বুলেন্স সার্ভিস		
	ক. সচল কি না	হ্যাঁ	না
	খ. এম্বুলেন্স সার্ভিস থেকে আয় (আগের মাসের)		
	গ. এম্বুলেন্সের তেল বাবদ কত বাকি		

বছর	**ইমার্জেন্সি**	**আউটডোর**	**ইনডোর**	**ইওসি ভর্তি**	**শয্যা ব্যবহারের হার (%)**
২০১৮					
২০১৯					
২০২০					
২০২১					
২০২২					

নিরাপদ মাতৃত্বসেবা

বছর	গর্ভবতী সংক্রান্ত ১ম ভিজিট	গর্ভবতী সংক্রান্ত ৪র্থ ভিজিট	সর্বমোট ডেলিভারি	ডেলিভারি		পিএনসি	
				নরমাল	সিজার	পিএনসি ১ম	সর্বমোট ডেলিভারি
২০১৮							
২০১৯							
২০২০							
২০২১							
২০২২							

জেলা-উপজেলায় চৌগাছা-ঝিনাইদহের আদর্শে স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা সম্প্রসারণ:

SOP Number: 1

SOP Title: প্রাথমিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন

উদ্দেশ্য: হাসপাতালের সার্বিক কার্যক্রমের বর্তমান অবস্থা অর্থাৎ সরকারি সম্পদ ব্যবহার এবং বিভিন্ন সেবার গুণ ও পরিমাণগত অবস্থা নির্ণয় করে একটি মূল্যায়ন প্রতিবেদন তৈরী করা

কর্মক্ষেত্রসমূহ:

- প্রতিষ্ঠানের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস
- হাসপাতালের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা
- নিরাপত্তা ও কর্মপরিবেশ
- রোগ সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণ
- আর্থিক ব্যবস্থাপনা
- ঔষধ, যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি
- বিভিন্ন বিভাগের কার্যক্রমের অবস্থা
- কোন পুরস্কার বা প্রশংসা অর্জন

দায়িত্বসমূহ:

তত্ত্বাবধায়ক ও আবাসিক মেডিকেল অফিসারসহ বিভিন্ন ইউনিট প্রধানগণ

কার্যপদ্ধতি:

নির্ধারিত ফরম্যাট প্রস্তুতকরণ।

SOP Number: ২

SOP Title: সমস্যাসমূহ চিহ্নিতকরণ

উদ্দেশ্য:

- প্রতিষ্ঠানের সকল সমস্যা চিহ্নিতকরণের মাধ্যমে সমাধানের প্রাথমিক পথসমূহ বের করা
- প্রতিষ্ঠানটির সকল সম্পদ ব্যবহার করে সার্বিক উন্নতিতে ভূমিকা রাখা

কর্মপদ্ধতি:

- সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীদেরকে সমস্যা চিহ্নিতকরণের তাগিদ দেয়া এবং নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে জমা দেয়া
- সকল সমস্যাসমূহ একত্রিত করে বিভিন্ন ধরণের সমস্যাগুলোর শ্রেণীবিভাগ করা: ছোট, মাঝারী ও বড় সমস্যা
- প্রতি সপ্তাহে WIT কমিটির মাধ্যমে নতুন সমস্যা চিহ্নিত করা ও সমাধানের অগ্রগতির মূল্যায়ন করা

দায়িত্বসমূহ:

- QIC ও WIT কমিটি
- তত্ত্বাবধায়ক/ইউএইচএফপিও ও আবাসিক মেডিকেল অফিসারসহ বিভিন্ন ইউনিট প্রধানগণ

SOP Number: ৩

SOP Title: লক্ষ্যমাত্রা (Target) নির্ধারণ করা

উদ্দেশ্য:

- লক্ষ্যবস্তু (Target) সমূহ সম্পর্কে তার কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মধ্যে স্বচ্ছ ধারণা সৃষ্টি করা
- সরকারী কার্যক্রম সফলভাবে বাস্তবায়নের পরিকল্পনা করা
- লক্ষ্যবস্তু বাস্তবায়নের মূল্যায়নের মাধ্যমে তথ্যভিত্তিক দায়বদ্ধতা সৃষ্টি করা

কর্মপদ্ধতি:

লক্ষ্য ও লক্ষ্যমাত্রা

- ২০২৩ সাল নাগাদ সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা সংক্রান্ত লক্ষ্য ও লক্ষ্যবস্তু সম্পর্কে স্থানীয় প্রতিষ্ঠানের অবস্থার তথ্য সংগ্রহ এবং সংশ্লিষ্ট নির্ণায়কের (indicator) মাধ্যমে মূল্যায়ন করা
- মাসিক, ত্রৈমাসিক, ষান্মাসিক ও বার্ষিক হিসিএবে এইসকল লক্ষ্যমাত্রার অগ্রগতির মূল্যায়ন করা
- অগ্রগতিসমূহ কেন্দ্রীয়ভাবে ও সংশ্লিষ্ট বিভাগে প্রদর্শনী করা
- নতুন নতুন পদ্ধতি উদ্ভাবনের মাধ্যমে লক্ষ্য বাস্তবায়নের প্রক্রিয়াকে উৎসাহিত করা এবং তাকে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া

দায়িত্ব:

- তত্ত্বাবধায়ক/ইউএইচএফপিও ও আবাসিক মেডিকেল অফিসারসহ বিভিন্ন ইউনিট প্রধানগণ
- কমিউনিটি সহায়তা গ্রুপের সদস্যবৃন্দ

SOP Number: ৪

SOP Title: লক্ষ্যসমূহ বাস্তবায়নে সেবাদানকারীদের অঙ্গিকার অর্জন করা

উদ্দেশ্য:

- স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার মাধ্যমে সেবা দানকারী ও গ্রহীতার মাঝে পারস্পরিক আস্থা সৃষ্টি করা
- স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, প্রশাসন ও সরকারী কর্মকর্তা, সাংবাদিক, শিক্ষক সহ সমাজের বিশিষ্টব্যক্তিবর্গের সাথে আলোচনা করে সরকারী কর্মসূচি বাস্তবায়নের অঙ্গিকার করানো
- সেবাদানকারীদের কার্যক্রমে জনবান্ধব দৃষ্টিভঙ্গি অর্জন করা ও জনমন্ডলীর (ঈড়সসঁহরঃ) সহায়তার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা বুঝিয়ে অঙ্গিকার আদায় করা

কর্মপদ্ধতি:

- বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সাথে সম্ভব হলে ব্যক্তিগত পর্যায়ে, অন্যথায় দলবদ্ধভাবে মতবিনিময় করা
- বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার প্রতিনিধির সাথে মত বিনিময় করা
- বিভিন্ন সরকারী বিভাগের সাথে, বিশেষ করে অফিসার্স ক্লাবের সদস্যদের সাথে মতবিনিময় করা
- সেবাদানকারীদের সাথে ব্যক্তিগত ও গ্রুপ পর্যায়ে লক্ষ্য, উদ্দেশ্য নিয়ে আলোচনা করা এবং তাদের মতামত নেয়া

দায়িত্ব:

- তত্ত্বাবধায়ক/ইউএইচএফপিও ও আবাসিক মেডিক্যাল অফিসার সহ বিভিন্ন ইউনিট প্রধানগণ
- কমিউনিটি সহায়তা গ্রুপের সদস্যবৃন্দ

SOP Number: ৫

SOP Title: মূল্যবোধ ভিত্তিক কর্মপরিবেশ ও প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কৃতি গড়ে তোলা

উদ্দেশ্য:

- হাসপাতালকে একটি পবিত্র স্থান হিসেবে বিবেচনা করা এবং এর পবিত্রতা সংরক্ষণ করতে উদ্বুদ্ধ করা
- "কম খরচে কার্যকর সেবা" এ মূল্যবোধের ওপর ভিত্তি করে প্রতিটি কার্যক্রম পরিচালনা করা
- সেবাদানকারীগণ কর্তৃক রোগীদেরকে স্বজন হিসেবে বিবেচনা ও তাদের অসুস্থতাকে সংবেদনশীলভাবে ব্যবস্থাপনা করা
- কোনক্রমেই দুর্নীতির সাথে আপোষ না করা

কর্মপদ্ধতি:

- সরকারী নিয়ম-কানুন যথাযথভাবে জানানো ও মেনে চলতে সহায়তা করা
- সময়ানুবর্তীতা, পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ, দায়িত্বশীলতা এমনভাবে প্রদর্শন করা যেন প্রতিটি কর্মকর্তা ও কর্মচারী একটি আনন্দঘন পরিবেশে অবস্থান করেন
- কর্মকর্তা ও কর্মচারীদেরকে তাদের নৈতিকতা সম্পর্কে সচেতন করা
- প্রতিষ্ঠানের ভবন ও প্রাঙ্গনে মনীষীদের মানব সেবা সংক্রান্ত বাণী প্রদর্শন করা
- রোগীদের কাছ থেকে "মিষ্টি খাওয়া" বা "সন্তুষ্টি"র নাম করে অর্থ আদায়কে শূন্য সহনশীলতা প্রদর্শন করা

দায়িত্ব:

- তত্ত্বাবধায়ক/ইউএইচএফপিও ও আবাসিক মেডিক্যাল অফিসার সহ বিভিন্ন ইউনিট প্রধানগণ
- কমিউনিটি সহায়তা গ্রুপের সদস্যবৃন্দ

SOP Number: ৬

SOP Title: লক্ষ্য (Goal) বাস্তবায়নে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলা

উদ্দেশ্য:

- সরকারের সপ্তম পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনা ও সর্বজনীন স্বাস্থ্য সুরক্ষা বাস্তবায়নে জনগণকে সম্পৃক্ত করাকে একটি অপরিহার্য উপাদান হিসেবে চিহ্নিত করা
- সরকারী সক্ষমতাকে আরো কার্যকর ভাবে কাজে লাগানোর জন্য তথ্যভিত্তিক সচেতনতা গড়ে তোলা

কর্মপদ্ধতি:

- জনপ্রতিনিধি, স্থানীয় প্রশাসন, সরকারী কর্মকর্তা, সাংবাদিক ও বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার প্রতিনিধিদেরকে ব্যক্তিগত যোগাযোগ ও গ্রুপ ভিত্তিক আলোচনা করে উদ্বুদ্ধ করা
- স্বাস্থ্য সংলাপ চালু করা
- দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের নিয়ে একটি ছায়া কমিটি গঠন করা

দায়িত্ব:

- তত্ত্বাবধায়ক/ইউএইচএফপিও ও আবাসিক মেডিক্যাল অফিসার সহ বিভিন্ন ইউনিট প্রধানগণ
- কমিউনিটি সহায়তা গ্রুপের সদস্যবৃন্দ

SOP Number: ৭

SOP Title: মানসম্পন্ন সেবাদান বাস্তবায়নে ৫এস কাইজেন পদ্ধতি বাস্তবায়ন করা

উদ্দেশ্য:

- মানসম্পন্ন স্বাস্থ্যসেবা দানে প্রাথমিক কার্যক্রম হিসেবে ৫এস কার্যক্রম শুরু করে স্বাস্থ্যসেবা পরিবেশ তৈরী করা
- সরকারী সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করা
- স্বাস্থ্যসেবা দানকারীদেরকে সমস্যা চিহ্নিতকরণ, অগ্রাধিকার নির্ধারণ ও সমাধানের অগ্রগতি পরিমাপে প্রশিক্ষিত করা

কর্মপদ্ধতি:

- সেবাদানকরীদের ৫এস কাইজেন সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দেয়া
- বিভিন্ন ওয়ার্ড/ইউনিটে ডওঞ গঠন করা
- তত্ত্বাবধায়ক/ইউএইচএফপিও'র নেতৃত্বে ছওঈ গঠন করা এবং একজন ফোকাল ব্যক্তি নির্ধারণ করা
- কধরুবহ/চউঈঅ পদ্ধতি সম্পর্কে ধারণা দেয়া

দায়িত্ব:

- তত্ত্বাবধায়ক/ইউএইচএফপিও ও আবাসিক মেডিক্যাল অফিসার, ফোকাল ব্যক্তি

SOP Number: ৮

SOP Title: নিরাপদ রক্ত সঞ্চালন কার্যক্রম

উদ্দেশ্য:

- জরুরী প্রয়োজনে রোগীদের নিরাপদ রক্ত সরবরাহের ব্যবস্থা করা
- দ্রুততম সময়ে রক্ত সরবরাহ করা
- রক্তদাতাদের একটি দল গঠন করে একটি **চলমান রক্ত ব্যাংক** গঠন করা

কর্মপদ্ধতি:

- নিরাপদ রক্ত সঞ্চালনের জন্য একটি কক্ষ নির্ধারিত করা ও প্রয়োজনীয় আসবাবপত্রের ব্যবস্থা করা
- স্বেচ্ছা রক্তদানকারীদের মোবাইল ফোন নম্বর সহ একটি তালিকা প্রদর্শন করা
- তালিকাতে ২০০-৫০০ (কমপক্ষে) জনের একটি তালিকা প্রস্তুত করা
- দাতাদের রক্ত নিরাপদ কিনা তা পরীক্ষা সহজলভ্য করা
- রক্ত ব্যাংকের যোগাযোগ সার্বক্ষণিক (২৪/৭) সচল রাখা
- গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় দিবসগুলোতে রক্তদাতা সংগ্রহে সমাজের বিশিষ্ট জনদেও অংশগ্রহণ ঘটানো
- বর্ষশেষে রক্তদাতাদের উৎসাহিত করার লক্ষ্যে সম্বধ:না দেয়া
- গভীর রাত্রে রক্তদাতাদের যোগাযোগের দায়িত্ব পালন করার জন্য একটি বিশেষ দল গঠন করা

দায়িত্ব সমূহ:

- সেবাদানকারীদেরকে রক্তদানের গুরুত্ব বুঝিয়ে বলা
- জনগণকে সম্পৃক্ত করে রক্তদানকারীর সংখ্যা বাড়ানো
- গর্ভবতী মায়েদের রক্ত গ্রুপ সনাক্ত করে তাদের প্রত্যেকের জন্য একই গ্রুপের দু'জন সম্ভাব্য রক্তদাতার মোবাইল নম্বর সহ তথ্য মায়ের কাছে রাখা

বাস্তবায়নকারী

- তত্ত্বাবধায়ক/ইউএইচএফপিও ও আবাসিক মেডিক্যাল অফিসারসহ একটি উপকমিটি গঠন করা
- এ সংক্রান্ত WIT সদস্যবৃন্দ
- নির্ধারিত সময় পর পর এর অগ্রগতি পর্যালোচনা করা

SOP Number: ৯

SOP Title: আইএমসিআই কর্নার কার্যক্রম

উদ্দেশ্য:

- বহিঃবিভাগে আগত সকল শিশুর চিকিৎসা প্রদান ও প্রতিরোধ স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতন করা এবং জটিল রোগী রেফার করা
- বিভিন্ন সেবা উপকরণ ব্যবহারের মাধ্যমে কর্নারকে আকর্ষণীয় ও বিশ্বাসযোগ্য করা
- আগত রোগীদের সন্তুষ্টি অর্জন করা

কর্মপদ্ধতি:

- আইএমসিআই-এর জন্য একটি কক্ষ নির্ধারণ করা
- একজন মেডিক্যাল এসিস্ট্যান্টকে দায়িত্ব দেয়া
- প্রয়োজনীয় পরিমাণে স্বাস্থ্য শিক্ষা উপকরণ সংগ্রহ করা
- শিশুদের এঙইও-ঋঋঋ (গধরহঃবহধহপব ড়ভ মৎড়ঃিয পযধৎঃ, ড়ৎধষ ৎবযুফৎধঃরড়হ ঃযবৎধঢু, নৎবধংঃ ভববফরহম, রসসঁহব্লধঃরড়হ, ভধসরষু ঢ়ষধহহরহম, ভড়ড়ফ ভড়ৎঃরভরপধঃরড়হ, ভবসধষব বফঁপধঃরড়হ) সম্পর্কে মায়েদের ধারণা দেয়া

দায়িত্বসমূহ:

- সেবাদানকারীদেকে এর উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবহিত করা
- জনগণকে কর্নারের গুরুত্ব বোঝানো

বাস্তবায়নকারী

- তত্ত্বাবধায়ক/ইউএইচএফপিও, আরএমও
- ডওঞ এর সকল সদস্য কর্তৃক সময়ে সময়ে কাজের অগ্রগতি পর্যালোচনা

SOP Number: ৯

SOP Title: প্রসূতি সেবা (এএনসি) কার্যক্রম

উদ্দেশ্য:

- গর্ভকালে মায়েদের ও গর্ভস্থ শিশুদের সুস্থ রাখতে সাহায্য করা
- ঝুঁকিপূর্ণ মায়েদের চিহ্নিত করা
- প্রাতিষ্ঠানিক প্রসবে উৎসাহিত করা
- সরকারী হাসপাতালকে এমনভাবে জনবান্ধব করে গড়ে তোলা যেন মায়েরা এখানে প্রসব সেবা নিতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন
- গর্ভকালীন পরিচর্যা, প্রসূতি ও শিশু সেবা একই প্রতিষ্ঠানে দেয়ার জন্য প্রতিষ্ঠানকে প্রস্তুত রাখা

কর্মপদ্ধতি:

- গর্ভবতী মায়েদের পরিচর্যার জন্য আসবাবপত্র সহ একটি ভালো কক্ষের ব্যবস্থা করা
- একজন দক্ষ ধাত্রী (মিডওয়াইফ)কে দায়িত্ব দেয়া (নিবন্ধন সহ প্রাথমিক পরীক্ষা নিরীক্ষার জন্য)
- প্রসূতি মা ও তাদের সঙ্গিদের পৃথক স্বাস্থ্য শিক্ষা কর্নারে অডিও-ভিসুয়াল পদ্ধতিতে স্বাস্থ্য শিক্ষার ব্যবস্থা করা
- গর্ভকালে কমপক্ষে পাঁচ বার (গর্ভসময়ের ১-১২ সপ্তাহ, ১৫-২০ সপ্তাহ, ২৪-২৮ সপ্তাহ, ৩১-৩২ সপ্তাহ, ৩৬তম সপ্তাহ) স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান থেকে গর্ভকালীন সেবা নেয়া
- মায়েদের এ সংক্রান্ত সকল পরীক্ষার ব্যবস্থা রাখা
- প্রতিটি গর্ভবতী মাকে অভিজ্ঞ মেডিক্যাল অফিসার দ্বারা চিকিৎসা নিশ্চিত করা
- মায়েদের ব্যক্তিগত গোপনীয়তা রক্ষায় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া
- সেবাগ্রহীতাদের অপেক্ষা করার সময় যেন ন্যূনতম হয়, সেভাবে সেবা কার্যক্রম সংগঠিত করা
- সেবাদানকারীদের দৃষ্টিভঙ্গি ও আচরণ জনবান্ধব করা

দায়িত্বসমূহ:

- জনসচেতনতা বাড়ানো
- সেবাদানকারীদের এর গুরুত্ব সম্পর্কে অনুধাবন করা

বাস্তবায়নকারী

- তত্ত্বাবধায়ক/ইউএইচএফপিও ও আবাসিক মেডিক্যাল অফিসার
- ডওঞ এর সকল সদস্য কর্তৃক কার্যক্রমের পরিকল্পনা ও সময়ে সময়ে কাজের অগ্রগতি পর্যালোচনা

SOP Number: ১০

SOP Title: স্বাস্থ্য শিক্ষা কার্যক্রম

উদ্দেশ্য:

- জনগণকে স্বাস্থ্য সচেতন করা
- সেবাগ্রহীতাদের আচরণ পরিবর্তন
- সংশ্লিষ্ট স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানে প্রদেয় সেবাসমূহ সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করা ও এ সুযোগ ব্যবহারে উৎসাহিত করা
- সেবাদানকারী ও গ্রহীতাদের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলা ও তথ্য আদান-প্রদান করা
- জনগণের স্বাস্থ্য সম্পর্কিত সুপারিশ গ্রহণ করা

কর্মপদ্ধতি:

- স্বাস্থ্য শিক্ষার জন্য স্থান নির্বাচন করা
- বসার ভাল ব্যবস্থা করা
- গুরুত্বপূর্ণ সেবাগুলো পোস্টার ও অডিও-ভিসুয়াল পদ্ধতির মাধ্যমে উপস্থাপন করা
- বিষয় অনুযায়ী সাপ্তাহিক রোস্টার ও সে অনুযায়ী দায়িত্ব বন্টন করা
- স্বাস্থ্য শিক্ষা কার্যক্রমে দায়িত্বশীলদের সংশ্লিষ্ট করা
- যারা স্বাস্থ্য শিক্ষা দেবেন তাদেরকে প্রশিক্ষত করা
- স্বাস্থ্য শিক্ষা সংক্রান্ত রেকর্ডসমূহ সংরক্ষণ করা

দায়িত্ব:

- তত্ত্বাবধায়ক/ইউএইচএফপিও ও আবাসিক মেডিক্যাল অফিসার অন্যান্য মেডিক্যাল অফিসার সহ দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গ স্বাস্থ্য শিক্ষা পরিচালনা করবেন
- কমিউনিটি সহায়তা গ্রুপের সদস্যবৃন্দ স্বাস্থ্য শিক্ষায় অংশ নেবেন
- কাউন্সিলিংএর ব্যাপারে জনগণকে উৎসাহিত করবেন
- স্বাস্থ্য শিক্ষার ব্যাপারে সেবাদানকারীদের দৃষ্টিভঙ্গি/আচরণ পরিবর্তন করতে হবে

বাস্তবায়নকারী

- ইউএইচএফপিও, আরএমও সহ সকল অফিসারবৃন্দ

SOP Number: ১১

SOP Title: কার্যক্রমের তথ্যাবলি প্রদর্শন

উদ্দেশ্য:

- জনগণকে স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানের বিদ্যমান সেবাসমূহ সম্পর্কে অবহিত করা
- কোন্ কোন্ সেবা কোথায় পাওয়া যায়, তা অবহিত করা
- সেবাদানকারী ও গ্রহীতার মধ্যে তথ্য আদান-প্রদানের মাধ্যমে সম্পর্কেও উন্নয়ন ঘটানো
- স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমের অগ্রগতি দেখানো

কর্মপদ্ধতি:

- তথ্য সংগ্রহ করে তার যথাযথ মূল্যায়নের পর নির্ভরযোগ্য তথ্য প্রদর্শন করা
- প্রত্যেক বিভাগে তাদের নিজস্ব তথ্যগুরো আলাদা আলাদা ভাবে প্রদর্শনী বোর্ডের মাধ্যমে প্রদর্শন করা
- তথ্য প্রদর্শনের ক্ষেত্রে ৫এস কাইজেন নীতিমালা অনুসরণ করা
- প্রতিনিয়ত তথ্য হালনাগাদ করা
- জাতীয়ভাবে সারা দেশে একই ধরণের স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানের জন্য একই ধরণের প্রদর্শন পদ্ধতি চালু করা

দায়িত্বসমূহ:

- সেবাদানকারীদের নিজেদেরকে তথ্য সংগ্রহ ও এর প্রদর্শনের গুরুত্ব সম্পর্কে অবহিত হওয়া
- সেবাদানকারীদেরকে তথ্য থেকে সিদ্ধান্ত গ্রহণের সক্ষমতা তৈরী করা
- জনগণকে তথ্য অবহিত করা

বাস্তবায়নকারী

- তত্ত্বাবধায়ক/ইউএইচএফপিও ও আবাসিক মেডিক্যাল অফিসার
- পরিসংখ্যান কর্মকর্তা
- WIT এর সকল সদস্য কর্তৃক সময়ে সময়ে কাজের অগ্রগতি পর্যালোচনা

SOP Number: ১২

SOP Title: চৌগাছা ও ঝিনাইদহ স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনের মাধ্যমে বাস্তব জ্ঞান অর্জন করা

উদ্দেশ্য:

- সেবাদানকারী ও কমিউনিটি গ্রুপকে চৌগাছা-ঝিনাইদহ মডেল সম্পর্কে বাস্তব ধারণা দেয়া
- কার্যক্রম সফলতার দর্শন অবহিত করা
- কার্যক্রম বাস্তবায়নের গুরুত্ব ও কৌশল রপ্ত করা

কর্মপদ্ধতি:

- সেবাদানকারীদের মধ্য হতে দায়িত্বশীল ও উদ্যোগী মানুষদের বের করা
- কমিউনিটি সহায়তা গ্রুপের মধ্য হতে দায়িত্বশীল ও উদ্যোগী মানুষদের বের করা
- এ সব ব্যক্তিদের নিয়ে চৌগাছা-ঝিনাইদহ পরিদর্শনে যাওয়া
- সেখানে তাদের সাথে মত বিনিময়ের ব্যবস্থা করা, জনসম্পৃক্ত মডেল বাস্তবায়নের কৌশল সম্পর্কে অবহিত করা, এবং নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানে তা বাস্তবায়নের কর্মকৌশল তৈরী করা

দায়িত্ব:

- তত্ত্বাবধায়ক/ইউএইচএফপিও ও আবাসিক মেডিক্যাল অফিসার, ফোকাল ব্যক্তি
- কমিউনিটি সহায়তা গ্রুপের সভাপতি

SOP Number: 13

SOP Title: মডেল সম্পর্কে অভিজ্ঞ টেকনিকাল টিম গঠনের মাধ্যমে বিভিন্ন স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানে মডেল হাতে কলমে বাস্তবায়ন করা

উদ্দেশ্য:

- চৌগাছা-ঝিনাইদহ হতে বাছাই করা অভিজ্ঞ ব্যক্তিদেরকে দেশের বিভিন্ন জেলা-উপজেলা স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানে হাতে কলমে মডেল সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দিতে পাঠানো
- মডেল বাস্তবায়নকে আরো সৃজনশীল করা
- মডেল বাস্তবায়নে বিভিন্ন পদ্ধতি গঠনে সুনির্দিষ্ট ভূমিকা রাখা

কর্মপদ্ধতি:

- চৌগাছা-ঝিনাইদহ হতে অভিজ্ঞ চিকিৎসক, নার্স, ওয়ার্ড মাস্টার, এইচআই, এসআই-কে নিয়ে একটি দল গঠন করা
- প্রশিক্ষণার্থী প্রতিষ্ঠান নির্বাচন করা
- প্রশিক্ষণের সময়সূচি তৈরী করা

দায়িত্ব:

- জনসম্পৃক্ত সি-জে মডেল সম্প্রসারণ জাতীয় টেকনিক্যাল কমিটি

SOP Number: 14

SOP Title: কমিউনিটি সহায়তা গ্রুপ গঠন করা

উদ্দেশ্য:

- হাসপাতালের মানসম্মত চিকিৎসা কার্যক্রম পরিচালনা ও উন্নয়নের লক্ষ্যে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে সহায়তা প্রদান
- সরকারী কার্যক্রম বাস্তবায়নে জনগোষ্ঠীকে (Community) কার্যকর অংশগ্রহণ করানো
- সরকারী সম্পদের
- পাশাপাশি স্থানীয় সম্পদকে স্বাস্থ্য সেবা উন্নয়নে সমাবিষ্ট করা
- হাসপাতাল পরিচালনায় আর্থিক ও অন্যান্য বাধাসমূহ দূরীকরণে সহায়তা
- স্বাস্থ্য সেবা উন্নয়নে স্থানীয় সরকারের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা
- স্বাস্থ্য সেবা উন্নয়নের চ্যালেঞ্জসমূহ সম্পর্কে স্থানীয় নেতৃত্ব ও স্থানীয় সরকারী কর্মকর্তাদেরকে অবহিত করা ও এর মোকাবেলায় তাদেরকে সম্পৃক্ত করা
- স্বাস্থ্য সেবা কার্যক্রমে সেবাদানকারী ও সেবা গ্রহীতাদের পারস্পরিক আস্থা ও নিরাপদ পরিবেশ নিশ্চিত করা

- স্বাস্থ্য সেবা ও স্বাস্থ্য উন্নয়ন কার্যক্রমে গতানুগতিক আমলাতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গির বদলে সহযোগিতামূলক ও অংশগ্রহণমূলক ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি অনুসরণ করা

কর্মপদ্ধতি:

- হাসপাতালের মানসম্মত সেবা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য বিশেষ করে চিকিৎসার পরিবেশ রক্ষা, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, শৃংখলা ও নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ কার্যক্রম পরিচালনা ও পরিচালনায় হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে সহায়তা প্রদান
- সরকারী বরাদ্দ ও সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার ও রক্ষণাবেক্ষণ নিশ্চিতকরণে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে সহায়তা প্রদান
- চিকিৎসা সেবার চাহিদা পূরণ ও উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকারী বরাদ্দের পাশাপাশি স্থানীয় দাতা ও হিতৈষী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে সংশ্লিষ্ট করা এবং তাদের সহায়তায় একটি কমিউনিটি সাপোর্ট তহবিল গঠন এবং এ বিষয় প্রদত্ত নির্দেশনা অনুযায়ী তহবিল পরিচালনা
- চিকিৎসা সেবার চাহিদা পূরণে সমস্যা চিহ্নিত করা এবং স্থানীয়ভাবে তা সমাধানের লক্ষ্যে পদক্ষেপ গ্রহণ
- হাসপাতালে কর্মরত চিকিৎসক, নার্স ও অন্যান্য কর্মকর্তা কর্মচারীদের সেবা প্রদানে উৎসাহ প্রদান এবং দায়িত্ব পালনে গঠনসমূলক পরামর্শ প্রদান

দায়িত্ব:

- জেলাতে সিভিল সার্জন/তত্ত্বাবধায়ক
- উপজেলাতে ইউএইচএফপিও

SOP Number: ১৫

SOP Title: কার্যক্রমের অগ্রগতি মূল্যায়ন করা

উদ্দেশ্য:

- চৌগাছা- ঝিনাইদহের আদর্শে জনসম্পৃক্ত স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা সম্প্রসারণ কর্মসূচির উদ্দেশ্যগুলো পূরণ হচ্ছে কি না, তা পরিমাপ করা
- এ আদর্শ বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট এলাকার মানুষের স্বাস্থ্যের উন্নয়ন হচ্ছে কি না তা পমিাপ করা

কর্মপদ্ধতি:

- অগ্রগতি মূল্যায়নের নির্দেশক নির্ধারণ করা
- নির্দেশক অনুযায়ী তথ্য সংগ্রহ করা
- তথ্য বিশ্লেষণ করে প্রতিবেদন প্রস্তুত করা
- প্রতিবেদন অংশীজনদের কাছে বিতরণ করা

দায়িত্ব:

- চৌগাছা- ঝিনাইদহের আদর্শে জনসম্পৃক্ত স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা সম্প্রসারণ জাতীয় টেকনিক্যাল কমিটি

SOP Number: ১৬

SOP Title: **চৌগাছা-ঝিনাইদহ মডেলের প্রতিষ্ঠাতাদের এ মডেল সম্প্রসারণে সম্পৃক্ত করা**

উদ্দেশ্য:

- মডেল প্রতিষ্ঠাতাদের অবদানের স্বীকৃতি দেয়া
- কর্মজীবনে তাদের অভিজ্ঞতাসমূহকে মডেল সম্প্রসারণে কাজে লাগানো

কর্মপদ্ধতি:

- মডেলের প্রতিষ্ঠাতাদের তালিকা প্রস্তুত করা
- তাদেরকে মডেল সম্প্রসারণে কাজে লাগানোর কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুত করা

দায়িত্ব:

- কাজ সম্পাদনের জন্য জাতীয় টেকনিক্যাল কমিটি একটি উপ-কমিটি গঠন করবে

SOP Number: ১৭

SOP Title: পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ও সৌন্দর্য বর্ধন কার্যক্রম

উদ্দেশ্য:

- হাসপাতাল ও এর পার্শ্ববর্তী এলাকার পরিচ্ছন্নতা নিশ্চিত করা।
- হাসপাতাল সীমানার মধ্যে বাগান তৈরী ও সৌন্দর্য বর্ধন।
- হাসপাতাল পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতায় পৌরসভা তথা জনসাধারণকে সম্পৃক্ত করা
- হাসপাতালের বহিরাঙ্গনের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন করা

কর্মক্ষেত্র:

- হাসপাতাল প্রাঙ্গণ পরিষ্কার রাখতে জনগণকে উৎসাহিত করা।
- হাসপাতালের টয়লেট/শৌচাগারের পরিচ্ছন্নতা সংরক্ষণে রোগী ও তাদের এটেনডেন্টদের সম্পৃক্ত করা
- হাসপাতাল প্রাঙ্গনের নর্দমা নিয়মিত পরিষ্কার রাখা
- পাক্ষিক বা মাসিক ভিত্তিতে জনগণের অংশগ্রহণে হাসপাতাল পরিষ্কার করা।
- হাসপাতাল চত্বরে বাগান তৈরী
- সব্জি বাগান করে পুষ্টির গুরুত্ব প্রদর্শন করা
- ভেষজ বাগান করে দেশীয় চিকিৎসা পদ্ধতিকে উৎসাহিত করা
- বসার স্থান তৈরী করা।
- সৌন্দর্য বর্ধনের প্রয়োজনীয় অন্যান্য কাজ করা
- ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে 'মহা পরিচ্ছন্নতা দিবস' (ইরম ঈষবধহরহম উধু) পালন করা
- ক্যাম্পাস পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা রাখার প্রয়োজণীয়তা সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করা

দায়িত্বসমূহ:

- জনগণকে উৎসাহিত করা
- জনসচেতনতা তৈরী
- হাসপাতাল পরিষ্কার রাখার প্রয়োজন সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করা
- হাসপাতালের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখতে প্রয়োজনে আউটসোর্সিং এর ভিত্তিতে জনবল নিয়োগ করা। কমিউনিটি সহায়তা তহবিল হতে ব্যয় নির্বাহ করা

কার্যপদ্ধতি:

- তিন/ চার সদস্য বিশিষ্ট উপ-কমিটি গঠন।
- পরিচ্ছন্নতার মানোন্নয়ন ও সৌন্দর্য বর্ধনের জন্য করণীয় বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ।
- সচেতনতা বৃদ্ধিতে পদক্ষেপ গ্রহণ।

বাস্তবায়নকারী: WIT গঠন করা

SOP Number: ১৮

SOP Title: সার্বিক নিরাপদ পরিবেশ নিশ্চিতকরণ কার্যক্রম

উদ্দেশ্য:

- হাসপাতালের সার্বিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার দৃশ্যমান উন্নতি করে চিকিৎসা সেবার অনুকূল পরিবেশ তৈরী করা।

কর্মক্ষেত্র:

- হাসপাতালের চিকিৎসক ও অন্যান্য সেবাকর্মী, রোগী ও তাদের আত্মীয় স্বজনদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।
- হাসপাতাল প্রাঙ্গন দালালমুক্ত করা।
- মেডিকেল সার্টিফিকেট প্রদানে সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসরণ করা ও পুলিশ কেইস সমূহে অযাচিত হস্তক্ষেপ ও প্রভাবিত করার চেষ্টা প্রতিহত করা।
- হাসপাতালে অনাকাঙ্খিত পরিস্থিতি এড়ানোর জন্য র্পূাহেই উপযুক্ত ব্যবস্থা নেয়া, অনাকাঙ্খিত পরিবেশ সৃষ্টি হলে তা তাৎক্ষণিকভাবে ব্যবস্থাপনা করা।
- হাসপাতাল প্রাঙ্গন ধূমপান ও মাদকমুক্ত রাখার বিষয়ে সর্বোচ্চ সতর্ক থাকা।
- হাসপাতালে ঔষধ কোম্পানির প্রতিনিধিদের নির্দিষ্ট সময়ে প্রবেশাধিকার দেয়া।
- নিরাপত্তা জোরদার করতে হাসপাতাল সীমানা ঈঈঞঠ র আওতাভুক্ত করা।
- জরুরী বিভাগে অপ্রয়োজনীয় ব্যক্তিদের যাতায়াত নিয়ন্ত্রণ করা।

দায়িত্বসমূহ:

- জনগণকে উৎসাহিত করা।
- জনসচেতনতা তৈরী।
- যেসব স্থানে নিরাপত্তাকর্মীর অভাব রয়েছে সেখানে স্থানীয় ব্যবস্থাপনায় নিরাপত্তাকর্মীর ব্যবস্থা করা।
- অনাকাঙ্খিত পরিস্থিতি মোকাবেলায় স্থানীয় জনগণের সমন্বয়ে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থাপনার উদ্যোগ নেয়া।

কার্যপদ্ধতি:

- তিন/ চার সদস্য বিশিষ্ট উপ-কমিটি গঠন।
- সচেতনতা বৃদ্ধিতে পদক্ষেপ গ্রহণ।

SOP Number: ১৯

SOP Title: সেবা কার্যক্রম

উদ্দেশ্য:

হাসপাতালে সেবার সার্বিক মানোন্নয়ন।

কর্মক্ষেত্র:

১. **জরুরী বিভাগ**

- জরুরী বিভাগে সার্বক্ষণিক মেডিকেল অফিসারের উপস্থিতিতে (উপজেলাতে অন কলে থাকা) চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করা।
- জরুরী যন্ত্রপাতি (যেমন: অক্সিজেন, গ্লুকোমিটার, নেবুলাইজার, জীবাণুমুক্তকরণ যন্ত্র), জীবনরক্ষাকারী ঔষধ এর সরবরাহ নিশ্চিত করা।
- সোলার সিস্টেম / আইপিএস এর মাধ্যমে সার্বক্ষণিক বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করা।

২. **বহির্বিভাগ:**

- বহির্বিভাগে রোগীদের জন্য অভ্যর্থনা কক্ষ/স্থান রাখা।
- গর্ভবতী মা, শিশু, পুরুষ, নারীদের জন্য পৃথক চিকিৎসা কক্ষ রাখা
- মুক্তিযোদ্ধা এবং প্রবীণদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা রাখা।
- স্বাস্থ্য শিক্ষা, আইএমসিআই, এএনসি/পিএনসি, ইপিআই, ব্রেস্ট ফিডিং, ওআরটি, এনসিডি, কৈশোর স্বাস্থ্য ব্যবস্থা পৃথক পৃথক কর্নারের মাধ্যমে কার্যকর সেবা দেয়া
- পরিচ্ছন্ন ওয়েটিং রুম ও লবি নিশ্চিত করা।
- চিকিৎসকের কক্ষের সামনে সুশৃংখল ব্যবস্থা গড়ে তোলা।
- বহির্বিভাগে অডিও-ভিসুয়াল মাধ্যমে স্বাস্থ্যশিক্ষার ব্যবস্থা করা।
- বহির্বিভাগে ঔষধ কোম্পানির প্রতিনিধিদের নির্দিষ্ট সময়ে প্রবেশাধিকার দেয়া।

৩. **অন্তঃবিভাগ:**

- সেবার মান বৃদ্ধিতে পদক্ষেপ গ্রহণ
- নার্সিং সেবার মান বৃদ্ধি ও জনবান্ধব নার্সিং সেবা নিশ্চিত করা
- সান্ধ্যকালীন রাউন্ড নিশ্চিত করা

৪. প্রসব পূর্ববর্তী, প্রসবকালীন ও প্রসব পরবর্তী সেবাসমূহ নিশ্চত করতে গর্ভবতী নারীদের রেজিস্ট্রেশন কার্ড নিশ্চিত করা।

৫. রোগীদের সকল পরীক্ষা হাসপাতালেই সম্পন্ন করা নিশ্চিত করা।

৬. স্থানীয় জনগণকে রক্তদানে উৎসাহিত করা ও সম্ভাব্য রক্তদাতাদের তালিকা সংরক্ষণ করা।

৭. বিকল যন্ত্র দ্রুত মেরামতের ব্যবস্থা নেয়া। প্রয়োজনে স্থানীয় ব্যবস্থাপনায় কম খরচে মেরামত সম্ভব হলে তার ব্যবস্থা নেয়া।

৮. সার্বক্ষণিক এম্বুলেন্স সুবিধা নিশ্চিত করা। কোন কারণে এম্বুলেন্স বিকল হলে স্থানীয়ভাব মেরামতের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

৯. হাসপাতালে সকলের জন্য নিরাপদ পানির ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।

১০. শৌচাগার সবার জন্য সহজলভ্য ও পরিস্কার রাখা।

১১. ডাক্তারদের ডিউটি রোস্টার ও সিটিজেন চার্টার প্রকাশ্য নেটিস বোর্ডে স্থাপন।

দায়িত্ব সমূহঃ

- হাসপাতালের সেবা কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য জনগণকে উৎসাহিত করা।
- জনসচেতনতা তৈরী।

কার্যপদ্ধতিঃ

- তিন/ চার সদস্য বিশিষ্ট উপ-কমিটি গঠন।
- সচেতনতা বৃদ্ধিতে পদক্ষেপ গ্রহণ।

SOP Number: ২০

SOP Title: রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ

উদ্দেশ্যঃ মহামারি বা বিশেষ রোগ উপদ্রুত এলাকাতে বিশেষ স্বাস্থ্যসেবার ব্যবস্থা রাখা ও জনগণকে সচেতন করা

কর্মক্ষেত্রঃ

- মহামারী বা অন্য কোন রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দিলে সে রোগ সম্পর্কে সচেতনতা তৈরীর জন্য রোগের লক্ষণ, কারণ, প্রতিকার, প্রতিরোধ ব্যবস্থা সম্পর্কে মাইকিং, ব্যানার, ফেস্টুনের ব্যবস্থা করা।
- প্রচার কার্যে সাধারণ জনগণকে সম্পৃক্ত করা

দায়িত্বসমূহঃ

- জনসচেতনতা তৈরি
- জনগণকে হাসপাতালের সেবা কার্যে সম্পৃক্ত করা

কার্যপদ্ধতিঃ

- তিন/ চার সদস্য বিশিষ্ট উপ-কমিটি গঠন

SOP Number: ২১

SOP Title : ঔষধ সরবরাহ ব্যবস্থাপনা

উদ্দেশ্যঃ

- হাসপাতালের সার্বিক সেবার সার্বিক মান উন্নয়ন

কর্মক্ষেত্রঃ

- ঔষধ সরবরাহ নিয়মিত ও নিরবিচ্ছিন্ন করা
- সরকারি ঔষধের সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করা
- অতি প্রয়োজনীয় ঔষধের সরকারি সরবরাহ শেষ হলে স্থানীয়ভাবে ক্রয়ের ব্যবস্থা করা

দায়িত্ব সমূহ ঃ

- জনসচেতনতা তৈরি
- জনগনকে হাসপাতালের সেবা কার্যে সম্পৃক্ত করা

কার্যপদ্ধতিঃ

- তিন/ চার সদস্য বিশিষ্ট উপ-কমিটি গঠন

SOP Number :২২

SOP Title: পথ্য সরবরাহ ব্যবস্থাপনা

উদ্দেশ্য ঃ

- হাসপাতালের সার্বিক মান উন্নয়নে অভিযোগ ও পরামর্শ বাক্স স্থাপন করে জনসাধারণকে সম্পৃক্ত করে সেবার সার্বিক মান উন্নয়ন

কর্মক্ষেত্র ঃ

- হাসপাতালে সরবরাহকৃত পথ্যের গুণগত মান নিশ্চিত করা
- হাসপাতালের রান্নঘর এর পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা নিশ্চিত করা
- হাসপাতালে সবার জন্য নিরাপদ পানির সরবরাহ নিশ্চিত করা

দায়িত্ব সমূহ ঃ

- জনসচেতনতা তৈরি
- জনগনকে হাসপাতালের সেবা কার্যে সম্পৃক্ত করা

কার্যপদ্ধতি ঃ

- তিন/ চার সদস্য বিশিষ্ট উপ-কমিটি গঠন

SOP Number: ২৩

SOP Title: অভিযোগ নিস্পত্তিকরণ কার্যক্রম

উদ্দেশ্য ঃ

- হাসপাতালের সার্বিক মান উন্নয়নে অভিযোগ ও পরামর্শ বাক্স স্থাপন করে জনসাধারণকে সম্পৃক্ত করে সেবার সার্বিক মান উন্নয়ন

কর্মক্ষেত্র ঃ

- হাসপাতালের প্রবেশ পথে অভিযোগ ও পরামর্শ বাক্স স্থাপন করা
- অভিযোগকারীর নাম/পরিচয়ের গোপনীয়তা রক্ষা করা হবে
- সাপ্তাহিকভাবে অভিযোগ ও পরামর্শ অনুযায়ী দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ

দায়িত্ব সমূহঃ

- জনসচেতনতা তৈরি
- জনগণকে হাসপাতালের সেবা কার্যে সম্পৃক্ত করা

কার্যপদ্ধতি ঃ

- তিন/ চার সদস্য বিশিষ্ট উপ-কমিটি গঠন

SOP Number : ২৪

SOP Title: তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবস্থাপনা

উদ্দেশ্যঃ

- হাসপাতালের সার্বিক মান উন্নয়নে ওঈঞ এর মাধ্যমে জনসাধারণকে সম্পৃক্ত করে সেবার সার্বিক মান উন্নয়ন

কর্মক্ষেত্র ঃ

- হাসাপাতালের সমস্যা সমাধানে ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাহায্যে নেওয়া
- নিরাপত্তা জোরদার করতে হাসপাতাল সীমানা ঈঈ ঈধসবৎধ আওতাভুক্ত করা

- সার্বক্ষণিক জরুরী হেল্প লাইন সার্ভিস চালু করা
- জরুরী টেলিমেডিসিন সেবা প্রদান
- স্বাস্থ্য শিক্ষার প্রসারে অনলাইন মিডিয়ার মাধ্যমে জনসাধারণকে কমিটিতে কাজ করার ব্যাপারে উৎসাহ প্রদান
- হাসপাতালের রোগীদের তথ্যাদি ডিজিটাল নথিপত্রের মাধ্যমে সংরক্ষণ
- অডিও-ভিসুয়াল মাধ্যমে ওয়েটিংরুমে/ অপেক্ষা ঘরে স্বাস্থ্য তথ্য প্রদান।

দায়িত্ব সমূহ ঃ

- জনসচেতনতা তৈরি।
- জনগনকে হাসপাতালের সেবা কার্যে সম্পৃক্ত করা।

কার্যপদ্ধতি ঃ

- ICT এর মাধ্যমে সচেতনতা বৃদ্ধিতে পদক্ষেপ গ্রহণ।
- তিন/ চার সদস্য বিশিষ্ট উপ-কমিটি গঠন

Building Blocks of C-J Model:

Sl. No.	Criteria of Chowgacha Model	Very good	Good	Poor
1.	Birth &Death recording		+	
2.	Health education Corner.			+
3.	Cleanliness & Beautification		+	
4.	Cycle-Van stand close to the main gate.		+	
5.	Display of the activities of the UHC (Field &health complex.)			+
6.	Blood donor list in Pathology dept		+	
7.	Separation of patient in OPD &IPD (Male, Female, Under5 & EOC)		+	
8.	IMCI-Corner.		+	
9.	ANC&PNC Corner		+	
10.	NCD-Corner		+	
11.	EPI & Breast-Feeding Corner			+
12.	ORT &Nutrition Corner			+
13.	Waste management		+	
14.	Moral based environment.		+	
15.	Implimentation of 5S KAIZEN		+	
16.	Community participation			+
17.	Reception Desk	+		
18.	Hospital Protocol board.			+
19.	Display of meeting schedule			+
20.	Knowledge about 7th5 yr. Plan & SDG.			+
21.	Display of information in every section			+
22.	VIA Service		+	
23.	Infection prevention activities.		+	
24.	Relation with local administration, OC & community leaders.		+	
25.	Positive media coverage		+	
26.	Publication of Annual Report.			+
27.	Position in HSS score of MIS in Feb-22.			237th
28	Video on UHC.			+

WIT: 1 **(EOC Ward)**

<u>Step 1:</u>Selection of Kaizen theme with feasibility check with Matrix Diagram

Possible KAIZEN Theme	Impact to patient outcome	Affordable in terms of time and resources	Easy to measure	Under control of team members.	Total Score
Implementation of partograph	5	3	3	4	15
Improve infection prevention	5	3	2	2	12
Improve labor room service with added component	5	5	5	4	19
Improve post-operative care among the operated patient	4	4	3	3	14
Maintain proper temperature, pulse, BP in the word	4	4	4	5	17

Step 2: Situation analysis

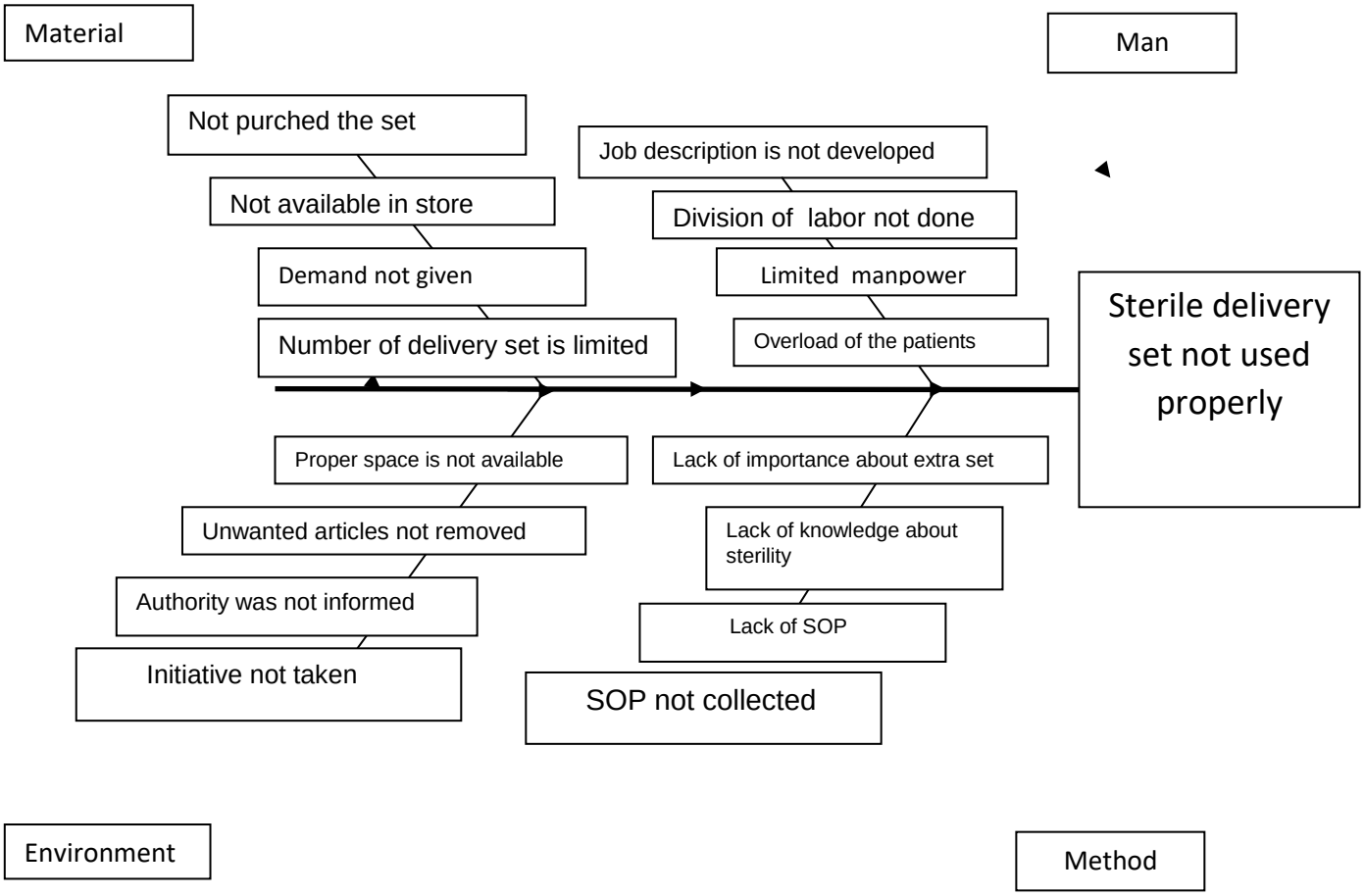
Kaizen theme: Labor room service improved with comprehensive services components.

Data collection method: Data collected by a WIT member through exit interview of 100 women who delivered in consecutive 20 days from 4th to 24th September.

Sl No	Contributing factors	Frequency	Cumulative frequency	Cumulative %
1	Sterile delivery set not used properly	34	34	40%
2	Labor room sister is not available.	15	49	63%
3	Chlorine solution is not used properly	12	61	71%
4	Counseling is not done	10	71	84%
5	Medical officer/Consultant is not supervise every case	6	77	90%
6	Labor room lighting system not functioning effectively	5	82	96%
7	Privacy is not maintained properly	3	85	100%

Step 3: Root cause analysis (Fishbone diagram):

Sterile delivery set not used properly



Step 4: Identification of actions/countermeasures

Root cause	Primary action	Secondary action	Importanc	Urgency	Difficulty	Time consumption	Resource availability	Total score
No initiative for extra manpower	Initiative for extra manpower	Identify the extra manpower	4	3	2	2	1	**12**
		Rearrangement of manpower	2	2	1	2	2	9
Delivery set was not available	Arrangement of good quality of delivery set	Purchase of delivery set	3	3	2	2	2	**12**
		Identify good quality of delivery set	3	3	2	2	2	**12**
No SOP for using sterility of delivery set	Arrangements of SOP for using sterile sets	Collection of SOP for sterility module	3	3	2	3	3	**14**
		pre and post training arrangement	3	3	3	2	2	**13**
Less number of nurses	Arrangement of extra nurses	Posting of new nurses	3	3	2	2	2	**12**
		rearrangement of nurses	3	3	3	2	3	**14**
No initiative of fund for sitting arrangement	Initiative for fund for sitting arrangement	Identify the probable cost of the chairs	3	2	2	2	2	11
		Identify the donors for the support	3	3	3	2	1	12
Not taken initiative for good quality chlorine solution	Indenting of good quality chlorine solution	Purchase of chlorine solution	3	3	2	2	2	**12**
		Orientation about the use of the solution	3	2	1	2	2	**10**
		Identify the person supervises regularly	3	2	2	2	2	**11**
Initiative not taken for supervision of sterility	Organize regular supervision system	Make a checklist for quality investigation	3	3	3	2	2	**13**
		Ensure regular on-the-job training	3	3	3	2	2	**13**
Initiative not taken for counseling	Arrange effective counseling system	Identify the points for counseling	3	3	3	2	2	**13**
		Regular monitoring the system of counseling	3	3	2	2	2	**12**

Step 5: Implementation of actions/countermeasures: action plan and progress monitoring for EOC ward (WIT-1)

Sl	Actions	Where	Who	When	Date of monitoring	Who	Progress
1	Identify the extra manpower	EOC ward	Consultant	20 to 30 Oct	28 Oct	RMO	
2	Purchase of delivery set	EOC ward	Hospital Super	30 Oct to 15 Nov	10 Nov	Super	
3	Collection of SOP	EOC ward	Consultant	15 to 20 Nov	18 Nov	Focal Person	
4	Posting of extra nurses	EOC ward	Hospital super	20 to 30 Oct	25 Oct	Focal Person	
5	Initiative for fund	EOC ward	Consultant	25 Oct to 5 Nov	30 Oct	RMO	
6	pre and post training arrangement	EOC ward	Store keeper	25 Oct to 15 Nov	30 Oct	RMO	
7	Identify the points for counseling	EOC ward	Hospital super	15 Oct to 20 Nov	17 Nov	Focal Person	
8	Regular monitoring the system of counseling	EOC ward	Team Leader	15 Nov to 20 Nov	17 Nov	Focal Person	
9	Purchase of chlorine solution	EOC ward	Hospital super	25 Oct to 10 Nov	5 Nov	Super	
10	Initiative taken for supervision	EOC ward	Hospital Super	30 Oct to 15 Nov	10 Nov	Super	

Step 6: Effectiveness of actions/countermeasures

Sl No	Contributing factors	Frequency		Frequency Reduction	Reduced%
		Before PDCA	After PDCA		
1	Sterile delivery set not used properly	34	10	24	71%
2	Labor room sister is not available.	15	3	12	80%
3	Chlorine solution is not used properly	12	2	10	83%
4	Counseling is not done	10	3	7	70%
5	Medical officer/Consultant is not supervising every case	6	1	5	83%
6	Labor room lighting system not functioning effectively	5	1	4	80%

7	Privacy is not maintained properly	3	0	3	100%